

Pré-natal

pediátrico





Para que serve a consulta pediátrica pré-natal?

1

Recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria no **3º trimestre da gestação** - redução de morbimortalidade perinatal, **através da antecipação de possíveis situações de risco** para o RN.

2

Os "**primeiros 1.000 dias**": da concepção aos 2 anos de idade do bebê.

3

Definição de **via de parto**, assim como assistência do neonato após o nascimento e dos cuidados com o recém nascido na maternidade.

4

Testes de **triagem neonatais**, procedimentos, vacinas e protocolos hospitalares.

5

Vínculo com o pediatra e alinhamento família - obstetra - pediatra; alinhar expectativas; fortalecimento de **rede de apoio**.

6

Amamentação e critérios de alta hospitalar.

7

Assistência pós parto e dúvidas!



1 O nascimento:



Como saber se seu bebê está bem?

Idade gestacional + tônus + respiração



Assistência imediata
com auxílio de uma
bolsa-válvula-máscara,
se necessário



- Aspiração de vias aéreas
- Intubação orotraqueal
- Massagem cardíaca e drogas

Escore de Apgar

	0	1	2
Frequência cardíaca	Ausente	Lenta (< 100bpm)	rápida (> 100bpm)
Respiração	Ausente	Lenta, irregular	Forte, choro
Tonus muscular	Flácido	Flexões nas extremidades	Movimento ativo
Irritabilidade reflexa ao cateter nasal	Sem resposta	Careta	Tosse, espirro
Cor da pele	Cianose central / palidez	Corpo rosado, cianose nas extremidades	Corpo e extremidades rosados

*Fonte: Organização mundial da saúde

2

A importância do pele a pele:

- Amamentar na 1ª hora de vida;
- Temperatura;
- Vínculo.



3 O exame físico do bebê:

O mais rápido para não
atrapalhar a amamentação



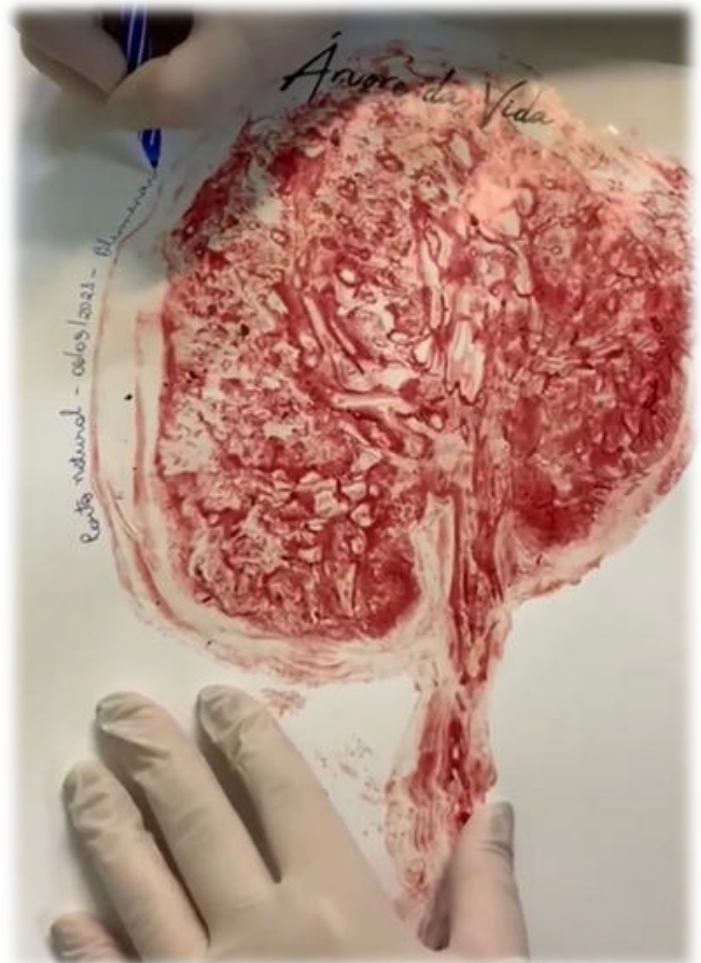
De preferência no
colo da mãe

No berço dentro do
quarto



SEMPRE
acompanhado pelo
pai ou familiar

Pesar e medir o bebê



Registro da placenta

4 Colírio de iodopovidona

Conjuntivite neonatal



5 Vitamina K

Doença hemorrágica do recém nascido



6 Banho após 6 a 24 horas

7

Vacinas – Vigilância Epidemiológica:

- BCG + Hepatite B.
- Próximas vacinas com 2 meses de idade

8

Testes de triagem neonatal:

a. Teste da linguinha: Frênulo lingual

- Frenotomia (se necessário)

O frênulo é uma estrutura anatômica muscular normal

4. Frênulo da língua



() é possível visualizar



() não é possível visualizar



() visualizado com manobra*

NO CASO DE NÃO OBSERVÁVEL VÁ PARA A PARTE II (Avaliação da Sucção não Nutritiva e Nutritiva)

4.1. Espessura do frênulo



() delgado (0)



() espesso (2)

4.2. Fixação do frênulo na face sublingual (ventral) da língua



() no terço médio (0)



() entre o terço médio e o ápice (2)

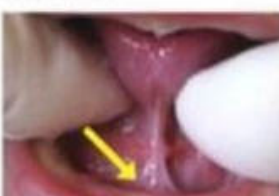


() no ápice (3)

4.3. Fixação do frênulo no assoalho da boca



() visível a partir das carúnculas sublinguais (0)



() visível a partir da crista alveolar inferior (1)

Queixas do bebê:

- Dificuldade de manter a pega
- Mamada descordenada
- Estalos , engasgo e tosse
- Ganho de peso inadequado
- Agitação / irritabilidade /
- choros Morde o seio
- Cansa para mamar

Queixas maternas:

- Dor e fissura mamária
- Baixa produção materna
- Ductos entupidos
- Desmame precoce

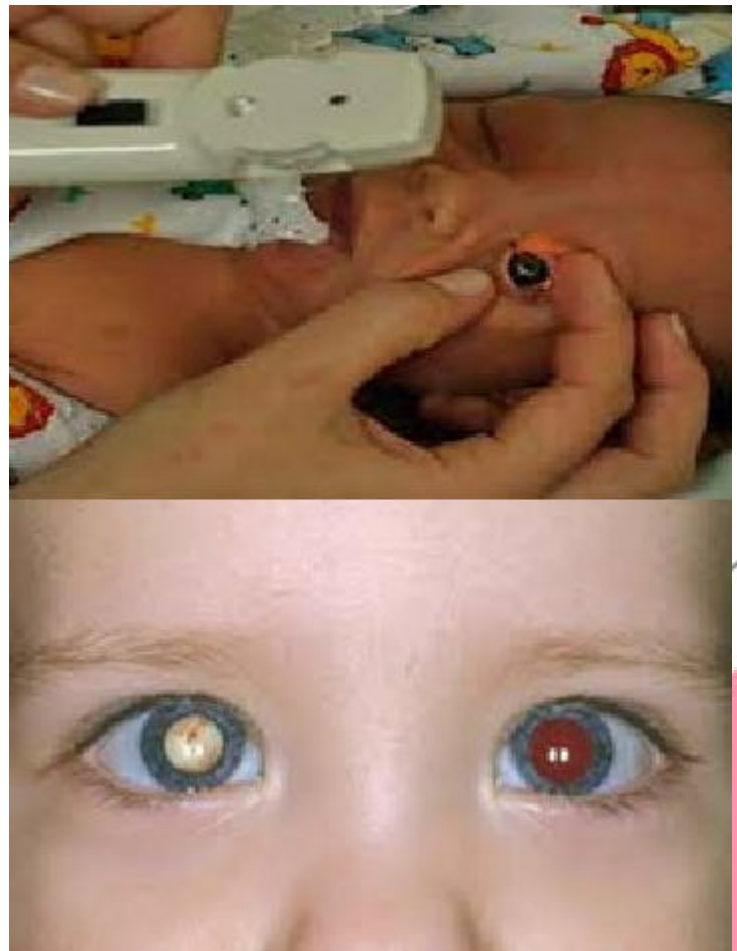
b. Teste da orelhinha

- exame de emissões otoacústicas evocadas
- produz um estímulo e capta o retorno



c. Teste do Olhinho: com auxílio de um oftalmoscópio

Retinoblastoma e
Catarata congênita



d. Teste do coraçãozinho

- com um oxímetro aferir a saturação de MSD e MID



e. Manobra de Ortolani



Fez xixi?
Fez cocô?
Vacinas?
Está mamando?
Está tudo bem?

Alta 
Hospitalar



Os 4 perrengues após a alta hospitalar

1. Amamentação:

- Sonolência nas primeiras 24h
- Estímulo pela descida do leite nos próximos dias
- Pega e posicionamento das mamadas
- Descida do leite entre 3 e 5 dias
- Consultoria de amamentação
- Banco de leite humano: (47) 3381-7570

2. Teste do pezinho entre o 3º e 5º dia de vida.

3. Icterícia neonatal

- Antes das primeiras 24 horas sempre necessita de internação hospitalar
- Pico entre o 3º e 5 dia de vida.

4. 1ª consulta com o pediatra entre 7 e 10 dias de vida.



CARTILHA PRÉ-NATAL



Com o bebê a caminho muitas coisas na dinâmica familiar já começam a mudar. Começamos a preparar o enxoval e o quarto, tudo à espera do nosso bem mais precioso.

Mas, o mais importante é o **CONHECIMENTO** e a **INFORMAÇÃO**.

Você receberá inúmeras “dicas” (vulgo palpites/pitacos) de parentes, vizinhos e amigos. Meus maiores conselhos são: **siga seus instintos e peça fraldas ao invés de palpites.**

Fique atenta às informações abaixo:

① O pediatra avalia a caderneta sua de pré-natal, observa se houve ou há alguma doença diagnosticada. Aproveite para tirar suas dúvidas e angústias em relação a isso.

② A prevenção de **doenças infecciosas** na gestação é importante! Por isso, a gestante deve estar com a sua carteirinha de vacinação em dia, assim como o pai e os familiares que estarão em contato com o recém-nascido.

3

A indicação da via de parto (parto normal ou cesariana) deverá ser a melhor para o binômio mãe-bebê. Tenha um planejamento por escrito de como deseja que seja seu grande dia, pois na hora do parto isso ajuda a nortear toda equipe.

Faça por escrito seu **“Plano de Parto”** e seu **“Plano de Contenção de Parto”**.



Precisa-se ter em mente: os benefícios da via de **parto natural** para o bebê e para a mãe, a recuperação materna mais rápida, menos risco de infecção, menos risco de taquipneia transitória do recém-nascido e amamentação do leite mais precoce.

A **cesariana**, como todo procedimento médico, tem sua indicação, e se assim for o melhor para o binômio, está tudo bem! Converse sempre com a equipe e principalmente com os médicos obstetras que estarão fazendo o atendimento.

4

Lembre-se de que a presença do pediatra no momento do parto é indispensável para um nascimento seguro.



5

O aleitamento materno é o melhor alimento para o bebê e deve ser ofertado de maneira exclusiva até os 6 meses de idade.



Seguem abaixo algumas dicas:

a) Cuidado e preparo das mamas: não use cremes nos mamilos ou esfregue com buchas. Pode pegar sol, mas a amamentação não requer outros tipos de “preparo “. Lembre-se de que todos os mamilos (e seios) são capazes de amamentar.

b) Início precoce da amamentação: na 1ª hora após o nascimento o bebê deve ser colocado para estimular, e se possível, sugar. Lembre-se de que nos primeiros dias o estômago do bebê é muito pequeno e ele não precisa de quantidade de leite, e sim, de QUALIDADE (coloostro) e muito aconchego.

c) Leite materno exclusivo até 6 meses, sem água, sem chás, sem sucos. A introdução alimentar deverá ser realizada após a liberação do pediatra, com 6 meses de vida ou mais.

A recomendação mínima de aleitamento pela SBP e Ministério da Saúde são 2 anos.

d) Pega adequada: aqui sugiro um maior investimento para que tenha sucesso na amamentação. Invista em vídeos, consultorias e acompanhamento para amamentação. Conheça o serviço do Banco de Leite (antiga Policlínica, próximo à rodoviária). O atendimento é gratuito e excelente, com equipe multidisciplinar.

e) Extração e conservação leite materno: 2h temperatura ambiente, 24h na geladeira, 15 dias congelado em vidro esterilizado ou em recipientes BPA free próprios para leite materno (protocolo brasileiro).

f) Chupetas e mamadeiras: esses são os maiores vilões causadores do desmame. Causam confusão de bicos, confusão de fluxo e menor frequência de estímulo ao seio materno. Se houver necessidade de complementar o aleitamento materno nos primeiros dias, este deverá ser feito na colher dosadora ou copinho e com orientação do pediatra assistente.

g) Aleitamento “cruzado” é contraindicado, ou seja, outra pessoa não pode amamentar o seu filho.





- **Teste do olhinho:** realizado na maternidade pelo pediatra, reflexo vermelho para diagnóstico precoce de retinoblastoma ou catarata congênita;
- **Teste da orelhinha:** realizado na maternidade pela fonoaudióloga, teste de triagem precoce para diversos diagnósticos de perda auditiva;
- **Teste da linguinha:** realizado na maternidade pelo pediatra e fonoaudióloga, diagnóstico de frênulo lingual curto (língua presa) – avaliar a necessidade de frenotomia a fim de evitar dificuldades na amamentação (dores e fissuras);
- **Teste do coraçãozinho:** realizado na maternidade pelo pediatra entre 24h e 48 horas de vida do bebê, para o diagnóstico precoce de cardiopatias;
- **Manobra de Ortolani:** realizado na maternidade pelo pediatra, diagnóstico precoce de displasia congênita de quadril;

Testes de triagem neonatal:

- **Teste do pezinho:** deverá ser coletado entre o 3º e o 5º dia de vida (geralmente feito após a alta). Doenças fenilcetonúria, hiperplasia adrenal congênita, hemoglobinopatias, fibrose cística e doença falciforme. Ampliado (20), plus (23), master (28), expandido (46) e completo (60) (conferir com o laboratório de referência);
- **Teste da bochechinha:** é um teste genético capaz de diagnosticar mais de 340 doenças genéticas que se manifestam na infância. O melhor momento para coleta é no primeiro mês de vida, podendo ser coletado até 1 ano de idade. Entre em contato com o laboratório de referência para maiores informações.



7

Ansiedade: Mais uma criança na família, sempre uma felicidade e uma expectativa muito grande para todos. Pense que você, tem suas convicções, maneiras de educar e criar e que não existe certo ou errado (desde que se respeite a criança). Nesse momento, o mais importante de tudo é a **REDE DE APOIO**.

Avós, tios e amigos nessas horas servem para dividir as funções durante o puerpério, pois os hormônios estarão super alterados e com isso terá muita labilidade emocional. Contem com eles SEM CULPA, e não tente fazer tudo sozinha. **Peça ajuda! Sempre!** E lembre-se de que o pediatra também é rede de apoio para vocês, ok?



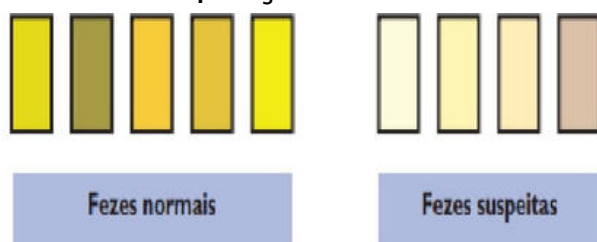
8

Puerpério: São os primeiros 60 dias após o parto. Serão os mais difíceis, além das alterações hormonais, há mudanças do corpo materno, privação de sono, medo de cuidar de um bebê tão pequeno, dificuldades para amamentar e lidar com opiniões de diversas pessoas.

A primeira coisa para a mãe fazer é **RESPEITAR o seu corpo** e essas mudanças que estão transformando-a em uma super heroína. Essa é a hora de acionar a rede de apoio. Não dê ouvidos às opiniões diversas. Atente-se a fazer o melhor dentro do que você acredita.

9

Eliminações: no início os bebês costumam evacuar após cada mamada, mas podem ficar até 9 dias sem fazer cocô, caso estejam em aleitamento materno exclusivo. Desde que não haja dor, isso é normal. As fezes sempre são semilíquidas ou pastosas e a coloração pode variar do verde para todos os tons de amarelo (ocre, mostarda, gema de ovo, alaranjado). **Não pode:** sangue nas fezes ou no xixi ou fezes esbranquiçadas.



10

Cólicas: um incômodo abdominal pode iniciar nos primeiros dias de vida, mas as cólicas iniciam-se na terceira semana de vida (por volta do 21º dia) e podem durar de 3- 4 meses.

Lembre-se: cólica é um choro INCONSOLÁVEL que dura pelo menos 3 horas por 3 dias seguidos. É comum o bebê apresentar gemidos, popularmente chamados de cólicas, que na verdade é **DISQUEZIA**, uma falta de conexão entre o cérebro e o intestino. Significa que o bebê tem imaturidade intestinal. Algumas medicações ajudam, e algumas técnicas como massagem relaxante e compressa morna na barriguinha também! Vamos ver isso na primeira consulta.





11

Sono: Nas 2 primeiras semanas de vida, o bebê mama de 2/2, 3/3 ou de 4/4 horas. Evitar tempo maior por risco de hipoglicemia e desidratação. Conforme vai crescendo, ele mesmo regula a frequência de sonecas e mamadas.

Dorme cerca de **16-20h por dia no primeiro mês**. Para um melhor sono é importante tentar organizar uma rotina. Exposição de luz e claridade pela manhã auxilia na regulação de hormônios de sono.

Durante o dia segue a livre demanda e, por exemplo, podem tentar **organizar uma rotina/ordem** de eventos: 16h dar um banho, 17h desligar eletrônicos e luzes e deixar na luz ambiente ou baixa, permanecer na companhia do seu bebê, brincando, fazendo contato visual, massagem, ruído branco... amamentar e fazer arrotar, ninar e fazer dormir.

Em questão de alguns meses vai perceber que criança gosta de **previsibilidade** e sente-se mais **segura**. Não deixe seu filho sozinho, chorando no berço, pois a liberação do hormônio do estresse causado por essas técnicas de treinamento do sono tem mostrado ser prejudicial.





12 Prevenção de acidentes:

Bebês devem dormir em **berços SEM cobertores, travesseiros ou bichinhos de pelúcia/brinquedos.**

No quarto dos pais, no mínimo até os 6 meses de vida. Sempre devem permanecer deitados de **barriga para cima.**

Em dias frios, use roupas mais grossas. Evite protetores de berço ou almofadas para prevenção da asfixia e a morte súbita do lactente.

Não os deixe sozinhos em uma superfície. Eles começam a rolar a partir 3-4 meses, mas não devemos contar com isso, pois cada bebê se desenvolve numa velocidade diferente.

Cuidado com bebidas quentes no momento da amamentação, podem ocorrer queimaduras na mamãe e no bebê.

Em caso de afogamento com leite não chacoalhe o bebê. Lateralize ou vire o bebê de barriga para baixo, posicione a cabeça um pouco mais baixa que o bumbum.

Leia ou assista vídeos sobre MANOBRA DE HEIMLICH EM BEBÊ.



BERÇO SEGURO

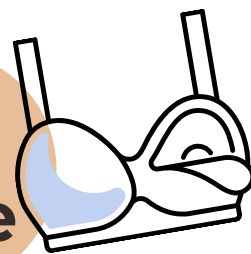


Cuidados gerais:

- a. Limpar bem o coto umbilical em todas as trocas de fralda, com **álcool 70%** até que caia.
- b. O **banho com água** deve ser realizado na temperatura de 36-37°C. Não existe uma necessidade de medir essa temperatura. Coloque a mão dentro da banheira ou embaixo do chuveiro e use o bom senso. A água deve ser de morna para fria.
- c. **Febre** é temperatura maior ou igual 37,8°C. Procurar o pediatra se ocorrer nos primeiros 45 dias de vida, evitar sair para locais fechados com muitas pessoas até pelo menos o 3º mês de vida (quando o bebê já tomou a primeira dose das vacinas mais importantes).
- d. **Restringir as visitas** de pessoas doentes. Solicitar àqueles que forem visitar, para que lavem as mãos e passem álcool gel.
- e. A **icterícia** (amarelão do recém-nascido) pode ocorrer dentro dos primeiros dias de vida e não deve passar do tórax para baixo. Caso esteja muito amarelinho, procurar o pediatra para avaliação.

**Tudo isso pode parecer difícil
e talvez seja, mas no final o
saldo é MUITO POSITIVO**

Sugestão de mala para a maternidade



Para a mamãe:

- Para o parto: caixinha de som e playlist das músicas, caso queiram;
- Camisola ou Pijama de amamentação com botões ou abertura frontal;
- Sutiãs de amamentação com sustentação;
- Calcinhas confortáveis, preferencialmente de cóc alto;
- Regatas de amamentação;
- Absorventes noturnos;
- Rosquinha de amamentação (lembrando que você pode fazer sua rosquinha com meias ou com fraldinhas de boca do bebê - evite o uso de absorvente de seio);
- Mudanças de roupas;
- Chinelo antiderrapante;
- Itens pessoais de higiene e cosméticos, prendedores de cabelo, sabonete, escova de dentes, creme dental, shampoo, escova de cabelo, toalha de banho e rosto, maquiagem, etc).



Sugestão de mala para a maternidade



Para o bebê:

- Roupas: 6 macacões, 6 bodies (ou pagãos) com calças ou mijãozinho; 3 pares de meias.
- Procure não utilizar amaciante ou perfumes na lavagem; usar sabão líquido neutro;
- Separe as roupinhas por época do ano;
- Não precisa exagerar nos agasalhos em épocas mais quentes.
- Retire etiquetas que podem irritar ou machucar o bebê;
- Separar as trocas e acessórios em saquinhos identificados, assim ajudará o papai e a equipe;
- Prefira roupas de tecidos orgânicos ou 100% algodão;
- Cueiros (manta fina) e/ou cobertor (principalmente para inverno);
- Fraldas (2 pacotes de fralda RN ou P);
- Toalha para banho;
- Fraldinha/ paninhos para boca (6 unidades);
- Itens de higiene: Shampoo ou sabonete neutro, pomada de prevenção de assadura, óleo corporal e/ou hidratante, álcool 70% para coto umbilical, tesoura de unhas, escova de cabelo, lencinhos,...



Obrigatório: bebê conforto para momento da alta (segurança em primeiro lugar sempre).

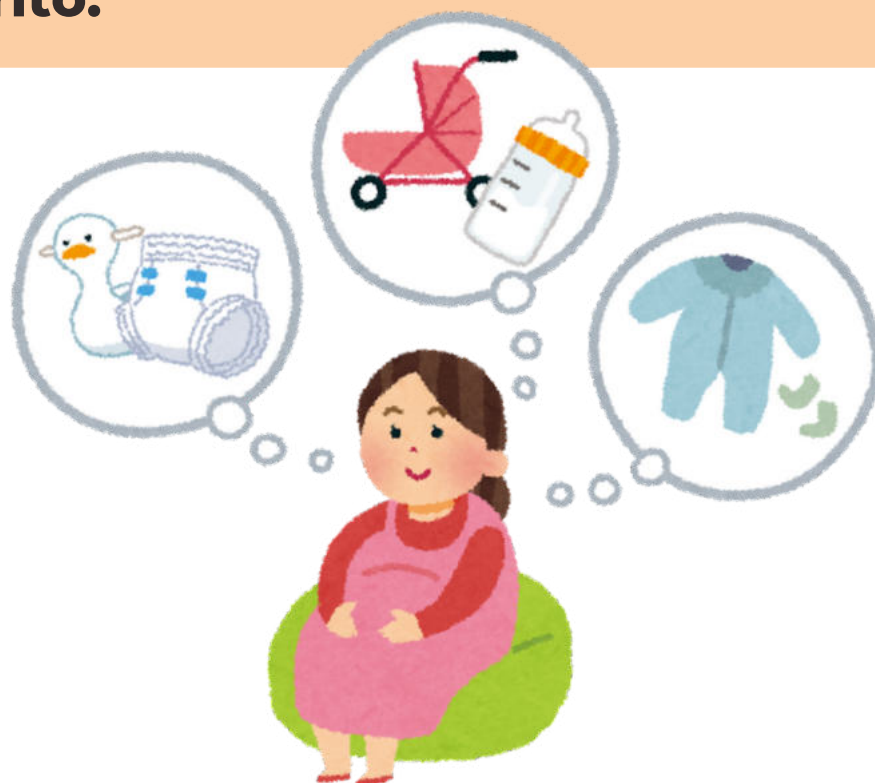
Não levar chupetas, mamadeiras ou outros bicos; evitar sutiãs com bojo ou ferro que sejam desconfortáveis;

Arranjos de flores ou enfeites de porta geralmente não são permitidos no hospital;

Não trazer brinquinhos, eles não podem ser colocados no ambiente hospitalar;

Opcional: lembrancinhas, livro de assinatura, capa ou livro todo de vacinas do bebê.

NÃO ESQUECER de levar todos os exames pré-natais, carteirinha de pré-natal, documentos pessoais, carteirinha do plano de saúde (se houver) e seu plano de parto por escrito.





Sugestões de itens de higiene para o seu bebê:

Produtos para a pele do bebê devem ser livres de substância irritantes e devem, ter o **pH ácido**, evitar em sua composição os alérgenos (parabenos, BHT, oliamidopropil, dimetila-7), essências de laranja, limão ou tangerina (ou qualquer outra essência forte), produtos coloridos artificialmente (corantes).

O **banho deve ser diário**, podendo ser espaçado em dias alternados desde que se realize higiene das pregas (dobras), coto umbilical e área da fralda.

Evite o uso de esponja ou qualquer outro material que “esfregue” na pele (panos, buchas,...).

O tempo total do banho não deve ser mais do que 10 minutos.





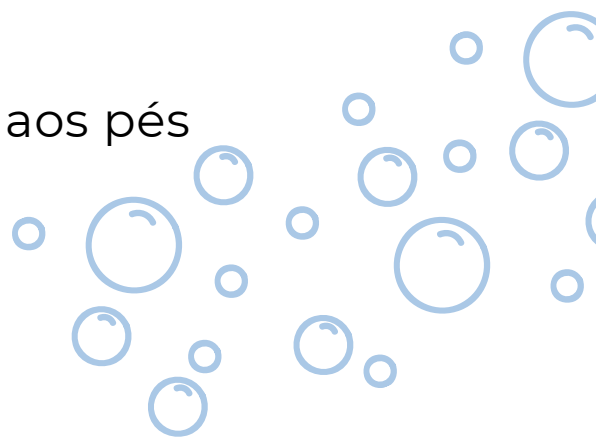
Sugestões de itens de higiene para o seu bebê:

Sabonetes: Prefira os sabonetes com adição de hidratantes e/ou sabonetes suaves sintéticos (sindets), de pH ligeiramente ácido (**pH entre 4,2 e 6,5**). Sugestões:

- Johnsons baby liquido
- Eucerin gel de limpeza
- La Roche Lipikar
- Mustela Intimate Cleansing Gel
- Mustela Gel Lavante Suave Corpo e Cabelo
- Cethapil Dermopediatrics Espuma de Banho da Cabeça aos Pés
- Huggies sabonete cream oil

Shampoo:

- Mustela Gel Lavante Suave Corpo e Cabelo
- Mustela Foam Shampoo for Newborns – especial para crosta láctea
- ISDIM Baby Naturals Gel Shampoo
- Johnsons baby liquido
- Huggies sabonete da cabeça aos pés



Sugestões de itens de higiene para o seu bebê:

Hidratantes:

- Cethapil Dermopediatrics Loção Hidratante
- Mustela Hydra Bébé
- Bioderma Atoderm Preventive
- ISDIM Baby Naturals Body Lotion
- Cerave
- Neutrogena Body Care
- Umiditá
- Aveeno



Creme preventivo para assaduras:

- Bepantol
- Weleda Calêndula Babycrème
- ISDIM Baby Naturals pomada regeneradora
- Hipoglós (tradicional ou Amêndoas)
- Desitin
- Mustela Vitamin Barrier Cream
- Opção de uso de óleos naturais (ex: óleo de coco, óleo de girassol) e observar como é a pele do bebê e como ele tolera.

Óleo de massagem: Óleo de coco, óleo Dersani baby, óleo Johnson, óleo Weleda baby, Mustela Huile de Massage.

Não utilizar perfumes ou colônias.

Protetor solar e repelentes apenas após sexto mês de vida.





Farmacinha para o bebê

- Paracetamol gotas 100mg/ml - para dor e febre (temperatura acima de 37,8°C)
- Simeticona gotas 75mg/ml - para gases e cólicas
- Soro fisiológico para limpeza nasal Maresis / Rinosoro / Salsep / Sorine
- Álcool 70% para higiene do coto umbilical (se preferência da família)
- Termômetro axilar digital
- Hastes flexíveis
- Algodão
- Lenço umedecido*



Obrigada

Espero que tenham
gostado e aproveitado
nossa consulta!

Eu desejo um excelente parto pra vocês e que
seja um momento repleto de felicidade!

Qualquer dúvida estarei a disposição!

